

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5062809-29.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: MARCOS ANTONIO GONCALVES DE ARAUJO

MEDIDA DE URGÊNCIA. CONSULTA ONCOLÓGICA. NEOPLASIA MALIGNA. INÍCIO DE TRATAMENTO. LEI Nº 12.732/12. PRAZO DE 60 DIAS ULTRAPASSADO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e archive-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2024.

5062809-29.2024.4.02.5101

510014382427 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5062809-29.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: MARCOS ANTONIO GONCALVES DE ARAUJO

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência interposta pela União em face da decisão do Juízo de origem que deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos:

"MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE ARAÚJO, pessoa natural qualificada e representada nos autos, propõe ação pelo rito dos Juizados Especiais Federais, com pedido de tutela de urgência, em face da UNIÃO FEDERAL, do ESTADO DO RIO DE JANEIRO e do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, objetivando a realização da a Consulta/Ambulatório 1ª vez - Neoplasias da Tireoide (Oncologia), bem como o início do tratamento oncológico adequado, em até 72 horas.

Parte autora patrocinada pela DPU.

Petição inicial instruída com documentos (ev. 1, inic1).

Termo de renúncia do montante que exceder 60 salários mínimos (ev. 1, anexo2, fl. 6).

Requerer a gratuidade de justiça (ev. 2).

É o relatório. Decido.

1- Defiro a gratuidade de justiça requerida, vez se tratar de pessoa representada pela DPU, condição da qual decorre a presunção de hipossuficiência. Ademais, os documentos com informações financeiras que acompanham a inicial corroboram tal circunstância (ev. 1, anexo2, fls. 3/4).

2 - A tutela de urgência está prevista no artigo 300 do CPC e possui os seguintes requisitos para o seu deferimento: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, o autor foi diagnosticado com nódulo tireoidiano na topografia de lobo direito de istmo da tireóide, com alta suspeição de malignidade, visualizado em ultrassonografia na data de 14/05/2024.

Afirma ter sido inserido no SER, em 28/05/2024, para Consulta/Ambulatório 1ª vez - Neoplasias da Tireoide (Oncologia), porém até a presente data está em fila, sem previsão para atendimento.

Pois bem.

Nos termos do art. 196 da CF/88, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Em verdade, configura-se direito de natureza fundamental, cabendo aos seus titulares a possibilidade de exigir que o Estado – entendido como a integralidade dos Entes federados – proveja todos os meios necessários ao gozo integral de saúde digna, aí compreendido o fornecimento de medicamentos, próteses, internações ou, ainda, intervenções cirúrgicas.

Nessa linha, veja-se que a vinculação da Administração Pública ao fornecimento de assistência integral à saúde decorre não apenas de interpretação do art. 196 da CF/88, mas, também, da leitura do art. 6º, inciso I, alínea “d”, c/c art. 19-M, inciso I, da Lei nº 8.080/90, que estabelecem o seguinte:

“Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

(...)

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;

Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea d do inciso I do art. 6º consiste em:

I- dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade com o disposto no art. 19-P

II - oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde - SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado.”

Embora a Carta Magna estabeleça que a saúde é direito de todos e é dever do Estado a sua promoção, cabe à Administração Pública a tarefa de organizar a forma de prestação desse serviço, fazendo-o por meio de critérios médico-científicos.

Dessa forma, o Judiciário não pode interferir, sem base em argumento técnico-pericial, na ordem de prioridade médica definida pelas administrações hospitalares, sob pena de causar-lhes ingerência indevida.

Nesse sentido é o Enunciado 51 da II Jornada de Saúde do CNJ:

“ENUNCIADO Nº 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, **com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.**”[gn]

A intervenção do Poder Judiciário só se legitima quando flagrante o desrespeito à ordem da fila de espera, ou em caso de risco iminente de morte, tudo em consonância com o princípio da igualdade que deve existir entre todos os pacientes.

Em relação ao tratamento de pacientes com neoplasia maligna no âmbito do SUS, a Lei nº 12.732/2012 estabelece que “o paciente com neoplasia maligna receberá, gratuitamente, no Sistema Único de Saúde (SUS), todos os tratamentos necessários, na forma desta Lei” (art. 1º).

Prevê, ainda, que “o paciente com neoplasia maligna **tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico** em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único” (art. 2º), e considera que “para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso” (art. 2º, § 1º).

A mesma norma ainda prevê, em seu artigo 2º, § 3º, que “**Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias**, mediante solicitação fundamentada do médico responsável.”

In casu, os documentos que acompanham a exordial comprovam o diagnóstico de neoplasia maligna, bem como o fato de o autor estar inserido no SER, desde 28/05/2024, para Consulta/Ambulatório 1ª vez - Neoplasias da Tireoide (Oncologia), sem previsão de atendimento, contudo (ev. 1, anexo2, fls. 7 e 13).

Resta, portanto, demonstrada a violação aos dispositivos da Lei nº 12.732/2012.

De toda sorte, não se pode prejudicar outras pessoas em igual ou até pior situação que a autora, e que têm, inclusive sobre a mesma, prioridade na fila organizada administrativamente, sob pena de afronta ao princípio da isonomia.

Isso porque não é o magistrado que deve determinar quais os indivíduos que serão agraciados por uma vaga em unidade de saúde especializada ou em qualquer outro hospital da rede pública, uma vez que o juiz não possui uma visão global acerca da situação dos demais pacientes, nem possui conhecimento sobre as prioridades, as enfermidades e a urgência de todos aqueles que aguardam ansiosamente a realização do mesmo tratamento.

*Ante o exposto, **DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA** para determinar aos réus o agendamento da consulta AMBULATÓRIO 1ª VEZ - NEOPLASIAS DA TIREÓIDE (ONCOLOGIA), com avaliação do quadro clínico do autor, em qualquer unidade de saúde pública apta a atendê-lo, se houver vaga e se tal não importar violação de urgência médica em relação a outros pacientes. **Prazo: 15 (quinze) dias.**"*

Em seu recurso, a União sustenta a carência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Afirma que a legislação estabelece o prazo mínimo de 60 dias para o caso de tratamento oncológico. Alega ainda a necessidade de observância da fila, bem como a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Subsidiariamente requer o redirecionamento para o Estado ou Município, nso termos do tema 793.

Efeito suspensivo indeferido no Evento 3.

É o breve relatório.

VOTO

Conforme ressaltado na decisão, a parte autora está aguardando desde 28/05/2024 para sua primeira consulta oncológica. Apresentou laudos médicos e exames que apontam a suspeita da malignidade da lesão, além do crescimento da mesma e piora progressiva da dor desde maio de 2024 (evento 1, ANEXO2 pag. 7 a 10)

A Lei nº 12.732, de 22.11.2012, que dispõe sobre o primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada no âmbito do SUS, assim estabelece:

"Art. 2º O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.

§ 1º Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso."

Da mesma forma, a Portaria nº 876/13 do Ministério da Saúde, que regula a aplicação da Lei nº 12.732/12, prevê que:

"Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a aplicação da Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, que versa a respeito do primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)."

"Art. 2º Para fins desta Portaria, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna comprovada com:

I - a realização de terapia cirúrgica;

II - o início de radioterapia; ou

III - o início de quimioterapia.

Parágrafo único. Os pacientes sem indicação das terapêuticas antitumorais descritas nos incisos I a III do "caput" terão acesso a cuidados paliativos, incluindo-se entre estes o controle da dor crônica, conforme protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde."

"Art. 3º O prazo de 60 (sessenta) dias fixado no art. 2º da Lei nº 12.732, de 2012, para fins do primeiro tratamento cirúrgico ou quimioterápico ou radioterápico do paciente no SUS, contar-se-á a partir do registro do diagnóstico no prontuário do paciente.

§ 1º O prazo previsto no "caput" poderá ser reduzido por profissional médico responsável, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.

§ 2º Não se aplica o prazo previsto no "caput" aos seguintes casos de neoplasia maligna:

I - câncer não melanótico de pele dos tipos basocelular e espinocelular;

II - câncer de tireoide sem fatores clínicos pré-operatórios prognósticos de alto risco; e

III - casos sem indicação de tratamento descritos no art. 2º."

Verifico que a parte autora até o momento não logrou atendimento, já estando aguardando em fila há mais de 60 dias. A demora na confirmação do diagnóstico e consequentemente início do tratamento adequado pode comprometer o quadro clínico do Autor, configurando, portanto, o *periculum in mora*.

No tocante à alegação de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão e da ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que a urgência e a necessidade da consulta oncológica encontram-se devidamente demonstradas nos autos, não cabendo afastá-las em razão de alegações genéricas e não comprovadas por parte da União.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, calha ressaltar que a não concessão da tutela antecipada por conta da ausência de tal requisito teria efeitos muito mais graves, deletérios e permanentes do que a eventual despesa financeira que o Poder Público possa ter.

Entendo, ainda, que deve ser aplicado o princípio da proporcionalidade para afastar a irreversibilidade do provimento adotado, a fim de que seja protegido o interesse maior lastreado no direito constitucional à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da CRFB/88, em detrimento do interesse financeiro do Estado.

No que diz respeito ao direcionamento do cumprimento da tutela de urgência, a 8.ª Turma Recursal já assim firmou seu entendimento:

"SAÚDE - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ENTE PÚBLICO, COM BASE NA TESE 793 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. *Em recurso onde ente federado alega ilegitimidade passiva, com fulcro na Tese 793 do Supremo Tribunal Federal, alegando que a atribuição de fornecer medicamento/tratamento é de outro ente federado, vale dizer, a interpretação mais consentânea com a jurisprudência do STF é a de que os cidadãos podem postular a concessão de tais medicamentos de todos os órgãos federados, sendo todos legítimos para a causa, porque fazem parte da relação jurídico-material primária, por força da Constituição Federal, sendo ainda, solidariamente responsáveis, com base no mesmo diploma. O que diz o tema 793 do Supremo Tribunal Federal é que o juiz do cumprimento da sentença irá direcionar o ofício para o devedor principal, em primeiro lugar. Assim, a discussão é se o ente federado é o devedor principal ou não, ou seja, aquele que será oficiado em primeiro lugar para cumprir a obrigação. 8 TR - Sessão de 11/06/2019 - Relator: LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA - Processo: 0190958222017402515102."*

Observa-se que nos autos de origem já houve o direcionamento do cumprimento para o Estado do Rio de Janeiro, nos termos dos Eventos 14 e 18.

Ressalto, ainda, que de acordo com informações dos autos de origem, a liminar já foi cumprida, tendo sido agendada consulta para a parte autora em 19/09/2024 (evento 29, DESPADEC1).

ISTO POSTO, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e archive-se.